リハ医療デイリー

REHA MEDICAL DAILY

2026年11月5日（木）

第54号　朝刊

きょうの紙面　▶脳卒中 × 上肢訓練　▶評価 × 基本動作　▶サルコペニア × 運動・栄養　▶短信 8本

■ 脳卒中 × 上肢訓練

上肢ロボット訓練にrTMS併用 改善幅が最大、順位はまだ確定せず

103試験・5,251人のネットワークメタ解析　確実性は非常に低〜中等度

脳卒中後の上肢の回復について、ロボット訓練だけの場合と、ロボット訓練に電気刺激・反復経頭蓋磁気刺激（rTMS）・経頭蓋直流電気刺激・VR・ブレイン・コンピュータ・インターフェースを組み合わせた場合を比べたネットワークメタ解析が、Archives of PM&R 2026年11月号に載った。中国語の文献データベースを含む7つを2026年8月まで検索し、ランダム化試験103件・5,251人を集めた。

上肢運動機能の指標FMA-UEで比べられた84件・4,277人では、通常ケアと比べた改善幅は、rTMS併用で9.56点（95%信頼区間7.18〜11.93）、低周波電気刺激の併用で7.52点、ロボット訓練だけで3.83点だった。rTMS併用は順位で1位となったが、「最も良い」確率は予測の不確かさを入れると77.8%から56.0%に下がった。

試験間のばらつきは大きく、組み合わせ同士を直接比べた試験は少ない。確実性は非常に低〜中等度で、著者らも決まった順位は付けられないとしている。回復期の上肢訓練に刺激を足すかどうかは、まだ直接比べる試験で確かめる段階と



足すほど良いかは、まだ決まっていない。

読むのが妥当だ。

出典 Archives of Physical Medicine and Rehabilitation ↗

数字で見る

9.56点
rTMS併用のFMA-UE改善（通常ケア比）

3.83点
ロボット訓練だけの改善

56%
不確かさ込みで最良の確率

■ 評価 × 基本動作

基本動作の尺度ABMS IIに歩行を追加 評価者2人の一致はICC 0.92

寝返り・起き上がり・座位・立ち上がり・立位の5項目で基本動作をみる国内の評価尺度「ABMS II」に、歩行の項目を加えた「ABMS II-w」の検者間信頼性の研究。歩行はバーセル指数にならい約45mを基準に6段階で付ける。大学病院のリハ科で49人（脳血管疾患11人、整形疾患30人など）を理学療法士2人が別々に評価した。

合計点の一致はICC 0.92、歩行の項目は重み付きκ 0.99、元の5項目



は0.69〜1.00だった。単施設・評価者2人で、妥当性や測定誤差はまだ調べていない。急性期の段階づけを回復期へそのまま渡せるかは次の検証しだいだ。

出典 Frontiers in Rehabilitation Sciences ↗

■ サルコペニア × 運動・栄養

握力と筋量は運動＋栄養が上位 TUGと歩行速度は運動が上位

サルコペニアやその手前の高齢者で、運動・栄養・その組み合わせを比べたネットワークメタ解析。ランダム化試験57件・6,017人を集めた。握力は3つとも対照より改善し、最も大きいのは併用で4.29kg、四肢の骨格筋量指数も併用が上位で0.32kg/m²増えた。

一方、TUGは運動で1.19秒短くなり、歩行速度も運動が上位だった。



確実性は全体に限られる。筋量と握力には栄養を足し、動作の速さには運動を軸にという組み立てを考える材料になる。

出典 Geriatrics & Gerontology International ↗

短信

〈情報管理〉医療機関もAI時代のサイバー対策を
厚労省がAIを使う攻撃の増加を踏まえ対策強化を要請。被害時は概要をまとめ速やかに報告を求める。 出典 GemMed ↗

〈心理〉脳卒中後の「主体感」の揺れを地図に
中国1施設の13人に退院6か月後に面接。主体感の喪失から再構築までを3段階に整理した質的研究。 出典 J Clin Nurs ↗

〈骨折〉フレイルの股関節骨折、全身麻酔で不利
米国の手術DBで3万人超を後ろ向きに比較。全身麻酔は脊椎麻酔より死亡・再入院・合併症と関連。 出典 Injury ↗

〈人工関節〉THA後30日以内の骨折は再手術が多い
全米DBの傾向スコア照合。2年で再手術のない割合は48.5%で、骨折なしの97.6%を大きく下回った。 出典 JBJS ↗

〈医療AI〉LLMは誤ったヒントに迎合しやすい
整形外科の問題で正答率78%が誤ったヒントで48%に低下。2モデルのみで結果の幅に注意が要る。 出典 JBJS ↗

〈骨粗鬆症〉内在的能力が低いほど骨折リスク高
閉経後女性200人の横断研究。聴力低下・低栄養・移動の制限がFRAXの高リスクと独立して関連。 出典 Osteoporos Int ↗

〈制度〉2024年度の国民医療費48.8兆円
前年度比1.5%増、1人当たり39万4300円。都道府県別の1人当たりは高知と埼玉で1.44倍の差。 出典 GemMed ↗

〈制度〉病院の病床、1年で1万5,823床減
厚労省の医療施設動態調査（8月末概数）。病院の病床は144万637床、施設は7,941で1年に63減。 出典 POST ↗